CAIRN.INFO
CHERCHER, REPÉRER, AVANCER

CHAPITRE III. « DOCTEUR, L'ALZHEIMER, À MON ÂGE, ÇA SE VOIT ? »

Une énigmatique altération des fonctions cognitives chez une patiente âgée de 40 ans

Marie-Pierre Guiho-Bailly, Patrick Lafond

Christophe Dejours, *Observations cliniques en psychopathologie du travail*

Presses Universitaires de France | « Souffrance et théorie »

2010 | pages 57 à 71

ISBN 9782130584353

Article disponible en ligne à l'adresse :

---

https://www.cairn.info/observations-cliniques-en-psychopathologie-du-trav--9782130584353-page-57.htm

---

Pour citer cet article :

Marie-Pierre Guiho-Bailly, Patrick LafondChapitre III. « Docteur, l'Alzheimer, à mon âge, ça se voit ? ». Une énigmatique altération des fonctions cognitives chez une patiente âgée de 40 ans, *in* Christophe Dejours, *Observations cliniques en psychopathologie du travail*, Presses Universitaires de France « Souffrance et théorie », 2010 (), p. 57-71.
DOI 10.3917/puf.dejou.2010.02.0057

Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Chapitre III

« Docteur, l'Alzheimer, à mon âge, ça se voit ? »

Une énigmatique altération des fonctions cognitives chez une patiente âgée de 40 ans

Marie-Pierre Guiho-Bailly[1]
Patrick Lafond[2]

L'attention portée à la vie professionnelle des patients, à la place du travail dans leur vie, dans leur fonctionnement mental, dans les altérations de leur santé ou dans

1. Marie-Pierre Guiho-Bailly est psychiatre, praticien attaché au CHU d'Angers, LEEST (Laboratoire d'ergonomie et d'épidémiologie en santé au travail), Université d'Angers.
2. Patrick Lafond est un ancien infirmier psychiatrique, thérapeute en relaxation.

leurs mouvements de restructuration ne va pas de soi pour les soignants en psychiatrie dans leur pratique clinique quotidienne.

Dans le cadre des soins psychiatriques, le travail du patient est évoqué le plus souvent sous l'angle de l'ergothérapie, de la « capacité » de travail, du reclassement professionnel : projets d'activités thérapeutiques ou de réhabilitation psychosociale, décisions à prendre en termes d'arrêt-maladie ou de mise en invalidité, accompagnement social dans une démarche de reconnaissance d'un *statut* de travailleur handicapé ou dans la recherche d'un *emploi* en milieu « ordinaire » ou « protégé », quand l'état psychique est jugé suffisamment stabilisé pour permettre une activité professionnelle.

Ce sont les caractéristiques de la pathologie psychiatrique, des troubles de la personnalité, des modalités évolutives de la maladie qui orientent la réflexion des cliniciens, en aval du projet de soins, sur le rapport à l'emploi pensé principalement en termes d'autonomie et d'insertion sociale.

L'absence de problèmes relatifs à l'emploi chez un patient qui consulte pour une décompensation psychique transitoire et dont l'état de santé ne paraît pas nécessiter un arrêt-maladie peut même faire évacuer complètement l'interrogation sur le travail.

On trouve trop souvent des dossiers médicaux dans lesquels les spécificités concrètes du métier exercé, l'itinéraire professionnel, les singularités du rapport subjectif au travail et de son évolution n'apparaissent nulle part, en dehors de la seule mention de la profession actuellement exercée, notifiée en un mot sur la feuille

de renseignements administratifs, et encore, lorsque cet item est renseigné…

Le plus souvent – en dehors des situations particulières où l'imputation d'une souffrance psychique à la situation de travail est mise d'emblée en avant par l'intéressé –, le patient participe lui-même à ce processus d'occultation, considérant que sa vie professionnelle « ne regarde pas » le clinicien, si ce n'est pour évaluer le retentissement temporaire de son état de santé sur son aptitude au travail.

La plupart du temps, les questions du patient consultant en psychiatrie rejoignent, à vrai dire, celles du praticien qui le reçoit : préciser la sémiologie des troubles, établir un diagnostic, formuler des hypothèses étiologiques en éliminant en premier lieu un problème somatique d'expression psychiatrique, puis en investiguant les éléments d'histoire personnelle, familiale, et les modalités structurelles du fonctionnement mental qui permettraient d'éclairer la clinique et d'orienter les propositions thérapeutiques.

Antécédents

C'est dans cette perspective classique de clinique psychiatrique que nous avions reçu en consultation Jeannine, 40 ans, mariée, deux enfants, que nous connaissions déjà pour l'avoir suivie quelque temps, trois ans auparavant, à la suite d'une tentative de suicide[1].

1. Une première présentation de cette histoire clinique a eu lieu le 6 décembre 1996 dans le cadre d'une communication conjointe

Lors de cette première période de prise en charge, Jeannine avait parlé de son geste suicidaire (une absorption médicamenteuse massive) comme d'une interrogation sur le sens de sa vie : donner l'alerte ou disparaître ?… L'intentionnalité reste mal établie, mais Jeannine sait qu'elle ne peut plus continuer à vivre sans se poser la question du sens de son existence, de ses priorités, de son « utilité », de sa féminité.

Il est beaucoup question du destin des femmes dans sa famille, de sa fille aînée qui vient de quitter la maison pour faire sa vie, de sa mère qui vieillit, de la façon dont elle-même a investi jusqu'ici son rôle de fille, de mère, d'épouse, de maîtresse de maison, fière de ses « dons », dit-elle, qui font d'elle une excellente cuisinière, une habile couturière, une décoratrice admirée pour la tenue de son intérieur, pour la beauté de son jardin, pour sa créativité, bricolant et innovant sans cesse…

Aucune autodévalorisation dans ses propos, pas d'atteinte de l'estime de soi, pas de doute sur ses compétences ni sur l'amour de ses proches, mais une appréhension anxieuse et une vision péjorative de l'avenir, du retour de la vie de famille à une vie de couple, du vieillissement, de la maladie, de la mort.

Ses enfants sont élevés et commencent à partir, tout est « achevé » dans la maison, son mari ne voit pas où est

avec Ghislaine Doniol-Shaw, ergonome-LATTS-CNRS, aux Rencontres européennes organisées par le groupe de recherche MAGE (Marché du travail et genre), sur le thème « Santé et travail ; emplois de service » (G. Doniol-Shaw, M.-P. Guiho-Bailly, « Emploi, conditions de travail et santé des employées dans les services », *Les Cahiers du MAGE*, 4/96, 15-33).

le problème… Comment affronter le temps qui reste à vivre ? Quel sens va prendre désormais sa vie ? Pourquoi et pour qui « continuer » ?

Jeannine avait formé depuis un moment le projet de rechercher « du » travail, mais ne trouve rien qui lui convienne, dans un marché de l'emploi tendu. Par ailleurs, son questionnement existentiel et la tentation suicidaire d'un moment entraînent des réminiscences portant sur l'histoire de son enfance, sur l'histoire familiale, suscitant une interrogation sur sa vie affective et sexuelle, et Jeannine s'engage dans une démarche psychothérapique.

Les capacités de mentalisation et de verbalisation sont de bonne qualité, les associations d'idées fructueuses, avec une richesse du fonctionnement préconscient, des rêves, des liens éclairants entre histoire personnelle et vécu subjectif actuel.

Peu à peu, le projet d'une activité professionnelle s'affirme et se précise ; en continuité avec les « qualités féminines » socialement valorisées qui ont étayé son identité dans les tâches domestiques et familiales, Jeannine recherche, de plus en plus déterminée, un emploi dans « les métiers du tissu » : habillement, décoration, couture, vente… Et elle trouve un poste d'employée de commerce dans un grand magasin récemment implanté et spécialisé dans l'habillement et le tissu d'ameublement.

Métier choisi, temps plein voulu, contrat à durée indéterminée d'emblée, distance minime entre le domicile et le lieu de travail… Tout se présente au mieux dans le projet professionnel de Jeannine, qui, par ailleurs, dans

un équilibre psycho-affectif retrouvé, met un terme à une psychothérapie dont elle ne sent plus le besoin.

Décompensation

C'est un an plus tard que Jeannine reprend un rendez-vous de consultation. Elle apparaît défaite, amaigrie, exténuée, presque hagarde. Elle se dit épuisée, irritable, souffrant d'insomnie, ralentie sur le plan idéo-moteur. Mais ce qui l'inquiète au premier chef, ce sont l'apparition et l'aggravation progressive, ces derniers mois, de troubles cognitifs et psychomoteurs.

D'emblée, Jeannine indique qu'elle ne reconnaît pas du tout dans son état actuel les symptômes de sa première décompensation, qu'il s'agit d'un état tout à fait différent… « Docteur, l'Alzheimer, à mon âge, ça se voit ? »

Jeannine perd la mémoire : elle ne sait plus où elle met ses affaires, ne termine pas ce qu'elle entreprend et qu'elle oublie en cours de route. Passant d'une activité à une autre sans même s'en rendre compte, elle retrouve ici et là dans sa maison les traces de tâches commencées et inachevées, sans qu'elle puisse se souvenir du moment et du motif de l'interruption.

Elle a des troubles majeurs de l'attention et de la concentration. Elle ne retient plus ce qu'on lui dit, n'arrive plus à suivre une conversation, « toujours en retard d'une question pour répondre », et peine à rassembler ses idées pour formuler une réponse pertinente. Les mots comme les pensées lui font défaut. Une idée chasse

l'autre et disparaît à son tour. Elle n'arrive plus à suivre une émission télévisée ou un film : elle perd le fil de l'intrigue, son attention est distraite à tout instant, sans raison réelle. Elle ne peut plus lire non plus, oubliant presque à mesure le contenu de la page précédente malgré son intérêt pour l'ouvrage.

Mais il y a pire, de son point de vue : elle ne sait « plus rien faire de ses dix doigts ». Elle, si fière de ses capacités manuelles, créatrices, est en train de perdre ses savoir-faire et devient de plus en plus maladroite. Tout lui échappe ; elle casse un objet après l'autre ; elle rate toutes ses recettes, même les plus simples et les plus habituelles ; elle ne sait plus comment réaliser des choses faites mille fois, comme si tout ce savoir accumulé, devenu automatisme du quotidien, source de plaisir et de fierté, s'était déconstruit.

Ce qu'elle arrive encore à faire lui prend maintenant un temps infini et ne lui donne jamais satisfaction, avec un goût d'inachevé et d'imperfection qui ne rend plus le résultat « présentable ». Comme si elle perdait toutes ses facultés. Comme si elle devenait démente.

Tous ces symptômes la terrorisent. Elle n'ose plus toucher à rien, se réfugie dans son lit dès qu'elle le peut, appréhende les occasions de réunions familiales et sociales, et commence à craindre pour son emploi, car, dit-elle, « au travail aussi », ses troubles commencent à lui jouer des tours, d'oublis en maladresses.

Devant cette perte de compétences et d'habileté vécue dans son intelligence et dans son corps, Jeannine se sent « plus vieille que folle », plus « malade » que dépri-

mée ou anxieuse. Avec une crainte majeure : être atteinte d'une pathologie cérébrale, d'une « sénilité précoce ».

Devant ce tableau clinique, un bilan somatique s'impose effectivement, visant à éliminer une souffrance cérébrale organique : métabolique, infectieuse, neurovasculaire, tumorale, neurodégénérative… Toutes les investigations s'avèrent négatives. Le bilan somatique est strictement normal.

Alors… c'est psychique ?…

Dans une perspective d'approche psychodynamique, nous faisons retour sur les événements de vie récents (pertes, départs, changements), sur la vie affective, sur le rapport subjectif au vieillissement, à la maladie, à la mort, déjà abordé il y a deux ans.

Contrairement à la précédente période de prise en charge, rien ne fait sens et les symptômes perdurent.

En échec dans cette démarche de psychothérapie verbale, constatant par ailleurs l'inefficacité d'un traitement antidépresseur d'« épreuve » et, à vrai dire, perplexes devant cette souffrance psychique et ce tableau clinique, nous proposons à Jeannine une approche différente associant :

– d'une part, des entretiens avec le psychiatre centrés pour l'instant sur l'actuel, le réel ;

– d'autre part, une approche psychocorporelle par technique de relaxation, menée par un autre thérapeute, infirmier spécialisé dans cette technique de soins, visant à mieux comprendre les liens entre vécus psychique et corporel et à aider Jeannine à se réapproprier ce corps qu'elle ne maîtrise plus et dont elle dit craindre qu'il ne la

« lâche » à tout moment, spectaculairement, et particulièrement sur son lieu de travail.

Dans le travail de relaxation, Jeannine fait l'épreuve des troubles qui l'affectent. Le thérapeute inscrit dans ses notes les observations suivantes : *« Mme B. insiste sur la sensation de précipitation, de crainte de ne pouvoir maîtriser le temps ; de ne pouvoir terminer et en fait de réaliser plus vite ou trop vite, sensation ressentie dans la vie tant professionnelle que familiale. »*

Le rapport au temps, aux rythmes, aux étapes, aux échéances, sera central dans la thérapie de relaxation de Jeannine : *« Elle entend un peu de l'induction et son esprit pense à autre chose. Elle n'entend pas, distraite, la suite de l'induction et craint d'avoir manqué des étapes. » « Elle s'aperçoit qu'elle fonctionne ainsi, y compris à son travail. Aujourd'hui, par exemple, elle fixe son idée sur l'annonce que la prochaine séance est dans un mois. »*

À l'issue de la psychothérapie de relaxation, le thérapeute soulignera que Jeannine a toujours fait, à chaque séance, le lien avec ce qu'elle vivait au travail, alors qu'elle n'a jamais évoqué son vécu antérieur ni sa décompensation psychique précédente.

« Comme à son travail », Jeannine, en séance de relaxation, ne peut suivre le cours de sa pensée, aller au bout de son projet, étape par étape. Sa pensée se disperse, la fuit ; son intention s'efface ; elle n'est plus sûre ni de ce qu'elle a réellement fait, ni de ce qu'elle a à faire.

Jeannine prend conscience que ce phénomène est accentué, voire produit, par deux ordres de « parasitage » :

– l'hypersensibilité aux *stimuli* externes, ici essentiellement auditifs : *« Elle dit qu'il lui est impossible de se concen-*

trer pour quelque activité que ce soit, que les moindres stimuli *la distraient immédiatement »* ;

– l'idée obsédante des tâches effectuées ou à effectuer : *« Son esprit vagabonde avec remémoration des activités de la veille ou anticipation des tâches à venir. »*

L'incapacité à se détendre comme à se concentrer s'accompagne d'un accrochage du fonctionnement mental au niveau perception-conscience : hypervigilance aux *stimuli* externes ; mise en panne du préconscient avec répression de la vie fantasmatique : *« Mme B. explique qu'elle n'a pas d'images parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer ; son esprit vagabonde, mais sans contenu, sans représentation. »* Seule échappatoire : la somnolence, la baisse de la vigilance. Mais « l'impossibilité de laisser venir des images » affecte Jeannine, qui repère bien le contraste avec son fonctionnement psychique « normal ».

Situation de travail

Parallèlement, dans les entretiens avec le psychiatre, Jeannine évoque l'évolution de sa situation de travail, depuis son embauche il y a plus d'un an dans un contexte d'organisation du travail où les marges d'autonomie étaient vécues comme satisfaisantes, avec un supérieur hiérarchique décrit comme compréhensif, une responsabilité de rayon partagée avec une collègue travaillant à temps partiel et avec laquelle la répartition des heures de travail était négociable, sous réserve d'assurer à elles deux la permanence d'accueil des clients dans ce magasin ouvert au public cinquante-deux heures par semaine.

La situation a évolué depuis, avec l'arrivée d'un nouveau responsable chargé de mettre en application les restructurations décidées par la direction générale nationale et visant à mieux gérer les effectifs en jouant sur une polyvalence au jour le jour et sur la flexibilité des horaires : accroître le nombre des tâches à effectuer par chacune des vendeuses, considérées comme interchangeables et chargées désormais tout à la fois d'assurer le service de la clientèle, de gérer les stocks, de passer les commandes, de réaliser la manutention des pièces de tissus ou des portants et caisses de vêtements, mais aussi de remplacer au pied levé dans un autre rayon une collègue absente ou indisponible, d'apprendre le travail aux nouvelles recrutées, toutes en contrat à durée déterminée.

Il devient, explique Jeannine, beaucoup plus difficile d'anticiper, d'organiser son temps déjà soumis aux irrégularités du flux de la clientèle. Il faut être partout à la fois, de façon souvent imprévisible. Les horaires de travail deviennent aussi irréguliers, parfois modifiés le jour pour le lendemain.

Mais le plus pénible à supporter pour Jeannine sont la perte d'autonomie et le manque de reconnaissance dans un travail désormais contrôlé en permanence par un responsable survolté, déniant son expérience et ses compétences, intervenant sans cesse pour donner l'ordre d'interrompre l'activité en cours et de se consacrer sans délai à une autre tâche jugée prioritaire et devant être finie avant d'être commencée…

L'ambiance s'est dégradée entre collègues. L'entraide spontanée a disparu, emportée par les prescriptions de

renfort au coup par coup, toujours vécues comme une surcharge de travail imposée de façon inéquitable, là où, auparavant, « donner un coup de main » aussitôt sa propre tâche achevée ne posait aucun problème.

La solidarité se construit difficilement avec les nouvelles embauchées qui sont perçues comme soumises et « muettes », du fait de leur statut précaire, ce que Jeannine comprend bien mais vit mal, dans un grand sentiment de solitude, car, par ailleurs, les anciennes disparaissent tour à tour, temporairement ou définitivement : arrêts de travail pour ulcère gastrique pour l'une, pour dépression pour l'autre, maternité non programmée mais bienvenue pour échapper au travail, démission…

Progressivement, Jeannine prend conscience que si elle « fonctionne » ainsi, « y compris à son travail », ce n'est pas parce que des troubles cognitifs, d'origine indéterminée, retentissent sur sa capacité de travail, mais bien parce que les nouvelles modalités organisationnelles de son travail déstructurent ses capacités cognitives, y compris, désormais, hors travail. Jeannine est « désorganisée ».

De leur côté, les thérapeutes, mettant en commun leurs observations, valident aussi cette hypothèse : les troubles cognitifs et psychomoteurs présentés par Jeannine ne sont pas la cause des difficultés rencontrées dans le travail, mais en sont la conséquence.

La polyvalence au coup par coup, l'obsession des échéances, l'interruption incessante de son activité par des ordres à exécuter sans délai (« *stimuli* auditifs » autant appréhendés que guettés, dans un « qui-vive » permanent) rendent impossible tout travail de suite, tout achèvement du programme psychomoteur en cours, et

dépossèdent Jeannine non seulement de son autonomie d'action, mais aussi de son autonomie de pensée.

Fil toujours rompu d'une activité désormais interdite d'initiative et qui se précipite, de plus en plus maladroitement, entre ordre et contrordre, entre flux irrégulier de la clientèle et imprévisibilité des tâches à effectuer, toujours inachevées, toujours présentes à l'esprit, saturant le champ de conscience de leur inaccomplissement…

Jeannine n'est plus satisfaite, et encore moins fière, de ce travail fragmenté, ni fait ni à faire, dont elle ne voit plus le bout, dont elle n'a plus une vue d'ensemble. Travail devenu pour elle irreprésentable et qui n'est plus guère présentable à l'évaluation d'autrui.

La prise de conscience des liens entre son état mental actuel et les caractéristiques de l'organisation du travail va entraîner chez Jeannine une diminution rapide de l'anxiété et des troubles du sommeil. Jeannine peut s'interroger alors sur la nature de ses troubles, là où elle réalise que d'autres salariées ont réagi autrement (ulcère gastrique, dépression) à une situation de travail en apparence identique pour toutes. Elle prend la mesure de son besoin personnel de maîtrise, de contrôle, de sa difficulté à perdre la main sur ce qu'elle entreprend, à accepter qu'on interfère ou qu'on procède autrement qu'elle.

Une séance de relaxation particulièrement marquante, pour son thérapeute comme pour elle, sera celle où Jeannine éprouvera comme une sensation nouvelle : le relâchement de sa tête et de son cou, sensation décrite comme une « découverte » et séance vécue comme une « libération ».

Jeannine finit par accepter un arrêt de travail, refusé jusqu'ici par crainte de perdre son emploi, dans la mesure où une intervention chirurgicale mineure et programmée lui permet de le légitimer. Dans le cadre de cet arrêt de travail de trois mois, tous les symptômes vont disparaître progressivement.

Ce constat conduit Jeannine à poser et à porter la question de la santé au travail. Le médecin du travail, contacté avec l'autorisation de Jeannine, confirme l'« épidémie » au sein du personnel de l'entreprise et nous informe de l'alerte déjà donnée à ce sujet ; Jeannine communique avec d'autres collègues, adresse à la direction générale un courrier cosigné avec l'une d'entre elles, également en arrêt de travail, puis effectue une démarche auprès de l'inspection du travail. L'engagement dans l'action contribue à sa restructuration psychique, dans le plaisir retrouvé de « fonctionner ».

La reprise de travail s'effectue tout d'abord en mi-temps thérapeutique, puis Jeannine négocie un temps partiel pour convenances personnelles « pour donner du temps au temps », avant d'opter pour une disponibilité d'un an, avec l'idée d'envisager une réorientation professionnelle en cas d'absence d'évolution de la situation dans l'entreprise.

Le médecin du travail a documenté son signalement et annoncé clairement à la direction son intention d'assurer une surveillance régulière, sur la durée, du risque constaté pour la santé des salariés.

Ultérieurement, des modifications vont intervenir dans l'organigramme et dans l'organisation du travail, avec un changement de responsable hiérarchique direct

et la réintroduction de marges d'autonomie dans la gestion collective du travail pour les salariées, améliorations jugées suffisantes par Jeannine pour qu'elle se risque, finalement, à reprendre son poste dans l'entreprise, sans que l'on constate la réapparition des symptômes et avec possibilité de mettre fin au suivi psychiatrique.

*

En psychiatrie, le travail des patients reste en réalité inconnu ; la place du travail dans la vie mentale, le rapport subjectif au travail demeurent inexplorés.

Malgré les indices qui jalonnaient le discours de Jeannine, il nous aura fallu des semaines – pour ne pas compter en mois – avant de pouvoir entendre ce qu'elle disait de son travail, tout à la fois issue sublimatoire et source de souffrance.

Il aura fallu se confronter à l'échec d'une approche compréhensive initialement exclusivement centrée sur la dimension psychofamiliale, sur la vie affective, avant de se risquer à aborder la dimension psychosociale de la vie mentale, avant que l'axe de notre investigation clinique ne se déplace et que notre écoute ne s'oriente vers la place, ici centrale, du travail dans la genèse des troubles actuels.

Bibliographie

DONIOL-SHAW G., GUIHO-BAILLY M.-P., « Emploi, conditions de travail et santé des employées dans les services », *Les Cahiers du MAGE*, 4/96, 15-33.